

Préparation QCM examen final!

Chirurgie thoracique

1. Cancer du poumon / plèvre
2. Tumeurs du médiastin
3. Traumatisme thoracique
4. Infections



Patient 70 ans, tabagisme chronique, dyspnée, crachats hémoptoïques...

Investigations supplémentaires?

Indiquer la réponse *la moins correcte*



- A. 👍 Déterminer les fonctions pulmonaires
- B. 👍 Obtention d'un diagnostic tissulaire (bronchoscopie)
- C. 👍 Exclusion de métastases à distance
- D. 👍 Exclusion de métastases ganglionnaires
- E. 👎 Thoracotomie exploratrice

Critères fonctionnels

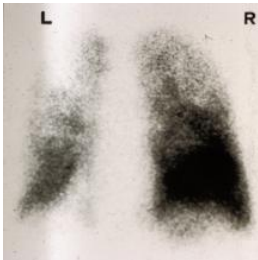


Emphysème, BPCO?
Maladies cardio-vasculaires associées?

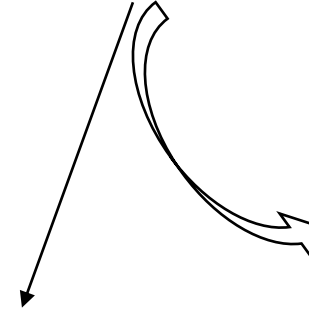


EVALUATION CARDIO-RESPIRATOIRE

VEMS, DLCO, $V_{O_2\max}$
Echocardiographie



Critères oncologiques



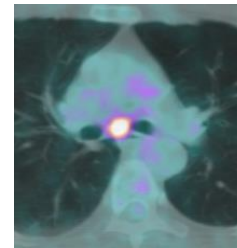
Situation palliative?

Situation potentiellement curative?



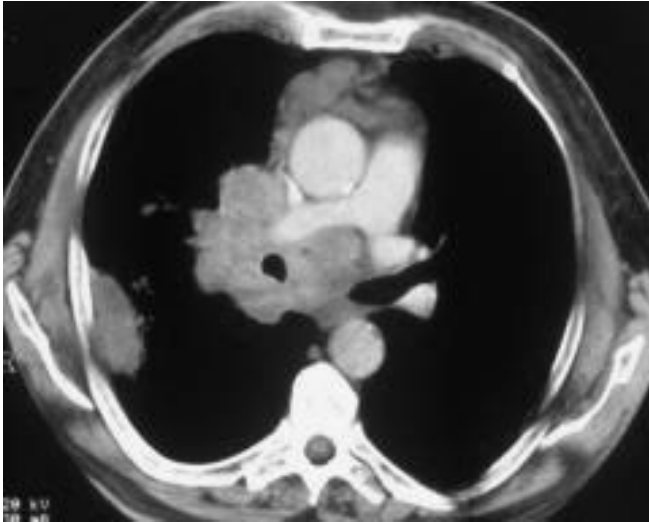
HISTOLOGIE ET STADE TUMORAL

Bronchoscopie, PET-CT, IRM cérébral



Atteinte ganglionnaire médiastinale?
PET + → EBUS

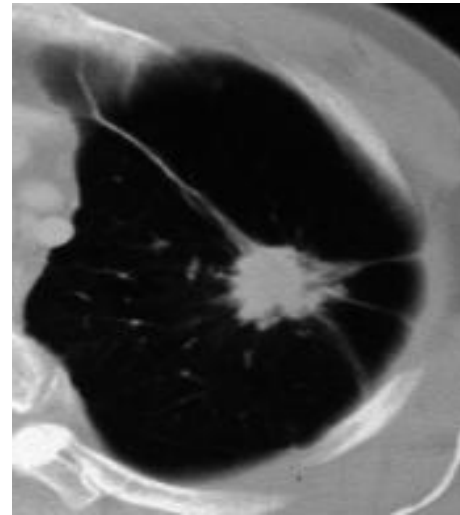
L'IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC ANATOMO-PATHOLOGIQUE



SCLC

Cancer à petites cellules (20%)

Chimiothérapie

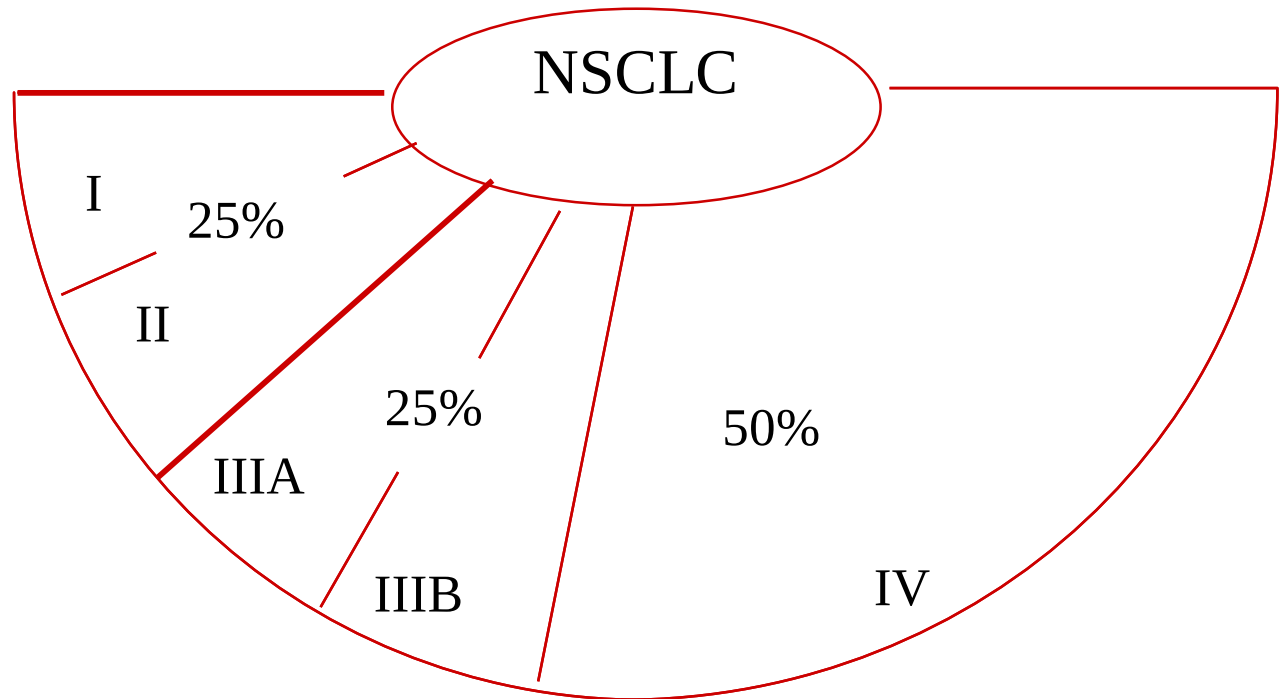


NSCLC

Cancer NON à petites cellules (80%)

Résection si patient opérable

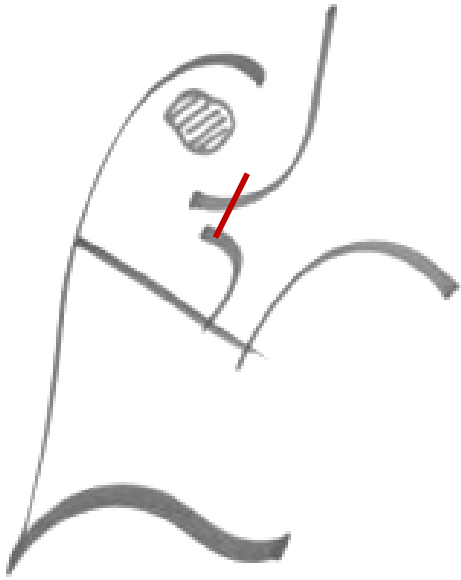
LE STADE TUMORAL DÉFINIT LE TRAITEMENT



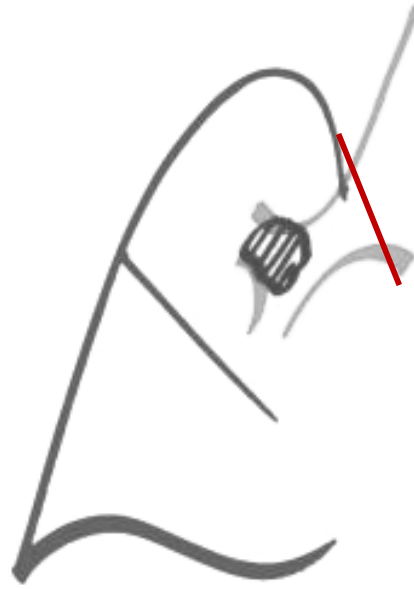
Stade I/II	Tumeur ne dépasse pas le poumon → Résection
Stade III	Tumeur dépasse le poumon mais pas la cavité thoracique → Traitements combinés
Stade IV	Métastases à distance → Chimiothérapie

STADE I/II NSCLC NE DÉPASSANT PAS LE POUMON

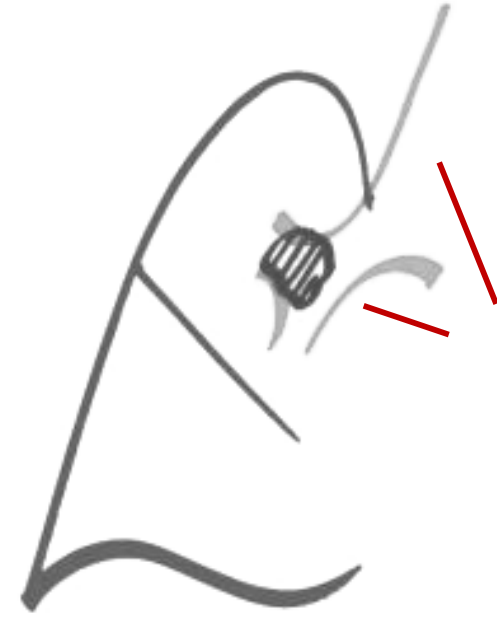
RÉSECTION ANATOMIQUE ET CURAGE GANGLIONNAIRE MÉDIASTINAL



NSCLC PÉRIPHÉRIQUE
Lobectomie/segmentectomie



NSCLC CENTRAL
Pneumonectomie



*Lobectomie en
manchon favorisé!*

STADE III NSCLC DÉPASSE LE POUMON MAIS PAS LE THORAX
TRAITEMENTS COMBINÉS (RT-CHT OU CHT → RÉSECTION)



Invasion des structures
avoisinentes

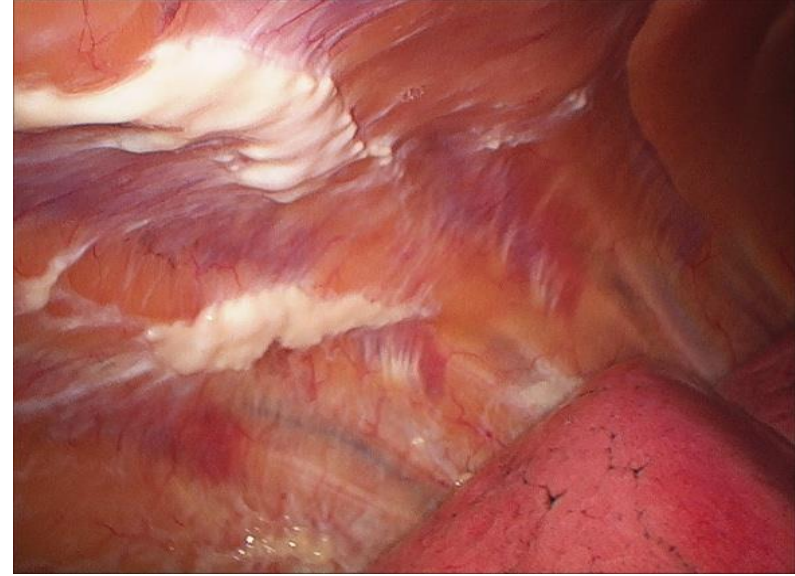
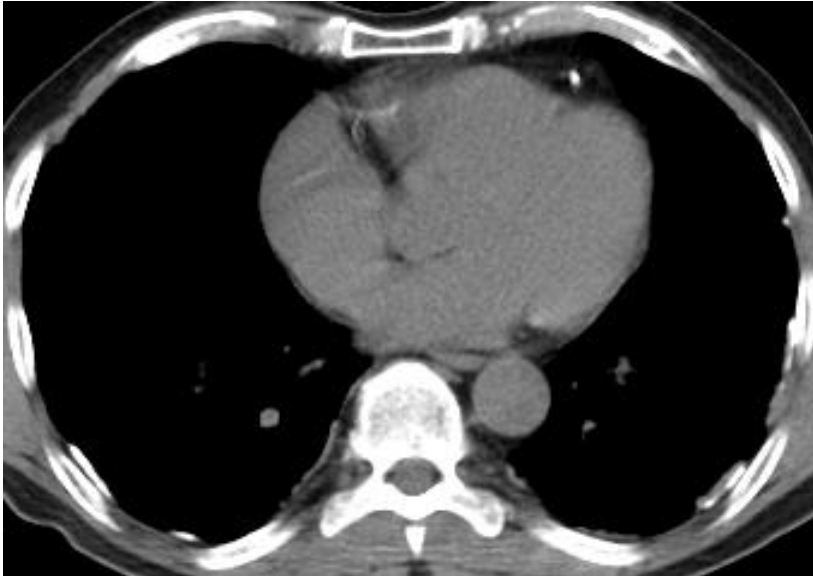


Atteinte ganglionnaire

Laquelle des affirmations suivantes est/sont vraie/s concernant l'opération d'un patient avec NSCLC sans métastases à distance :

- A  Une médiastinoscopie / EBUS doit être réalisée en cas de suspicion d'atteinte ganglionnaire médiastinale au PET/CT
- B  Une résection anatomique (lobectomie / segmentectomie) doit être réalisée si les fonctions pulmonaires le permettent
- C  Un curage ganglionnaire médiastinal lors de l'exérèse n'est pas obligatoire
- D  Pour des tumeurs centrales, une lobectomie en manchon est préférée par rapport à la pneumonectomie

Patient de 55 ans, exposition à l'amiante, découverte fortuite de la pathologie par CT→ thoracoscopie



- A. 📉 Mésothéliome pleural malin → ad résection
- B. 📉 Carcinose pleurale → ad talcage
- C. 📉 Tumeur fibreuse de la plèvre → ad résection
- D. 📈 Plaques pleurales → ad rien faire!

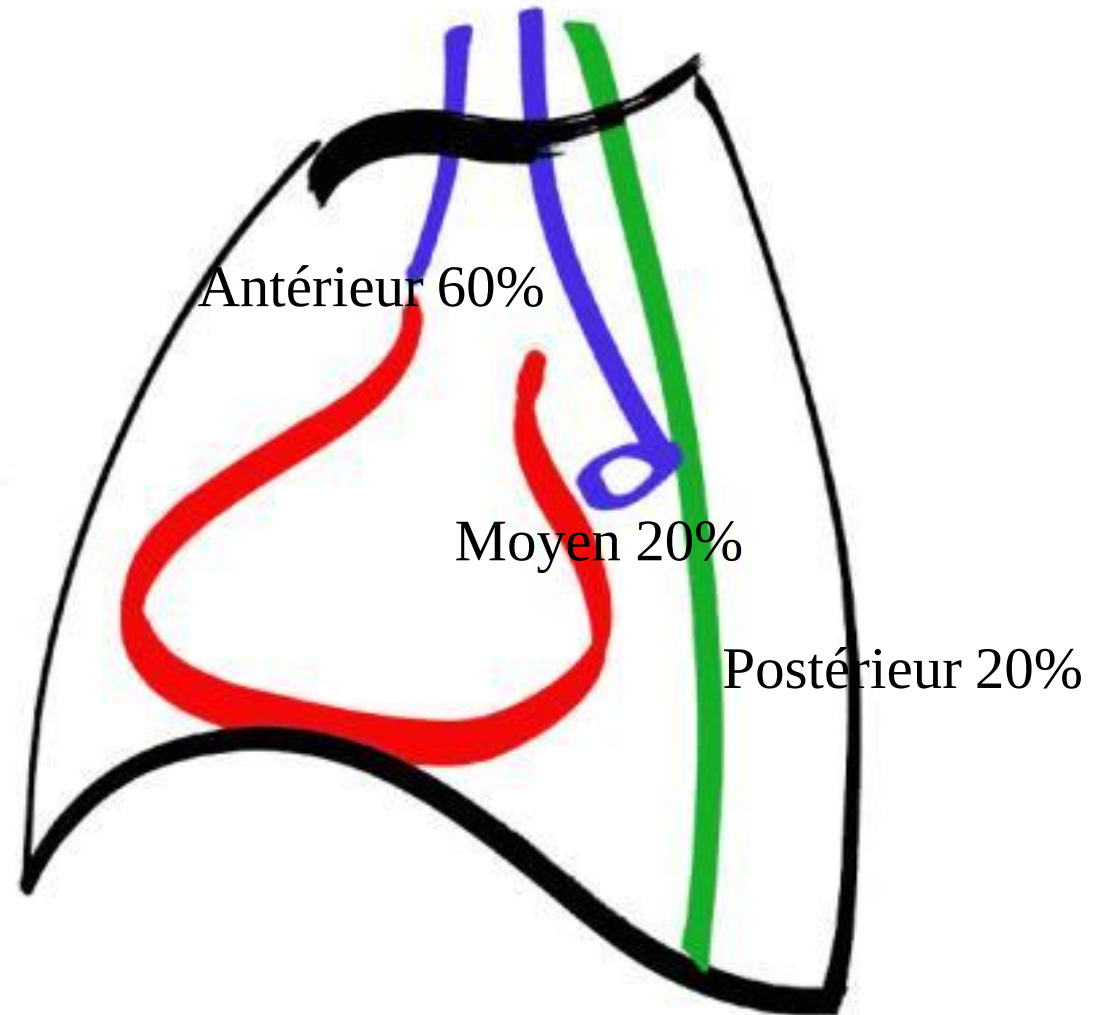
Préparation QCM examen final

Chirurgie thoracique

1. Cancer du poumon / plèvre
2. Tumeurs du médiastin
3. Traumatisme thoracique
4. Infections

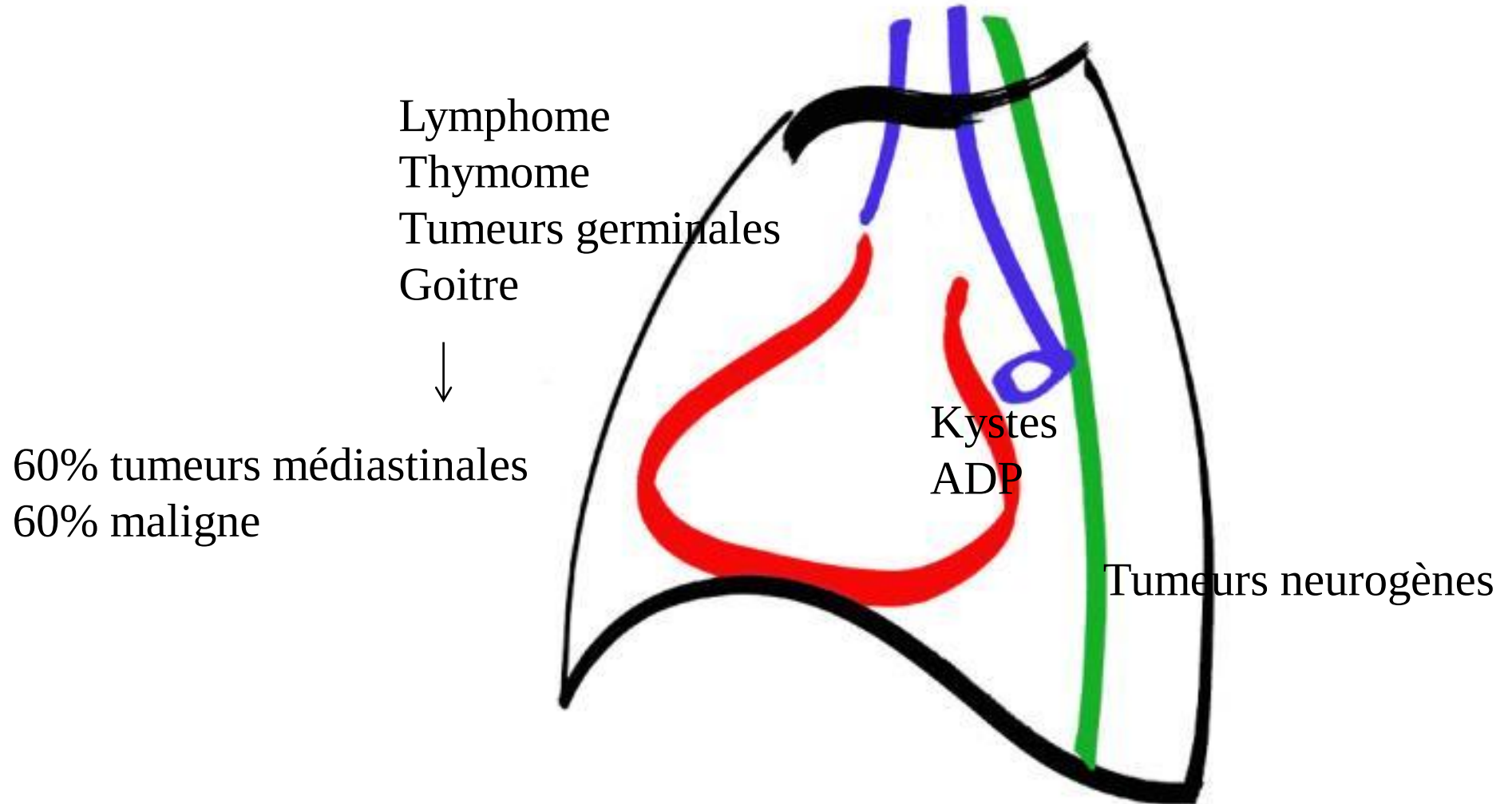
MASSES MÉDIASTINALES

RÉPARTITION SELON COMPARTIMENTS DU MÉDIASTIN



MASSES MÉDIASTINALES

RÉPARTITION SELON COMPARTIMENTS DU MÉDIASTIN



MASSES MÉDIASTINALES

SYMPTÔMES LOCAUX

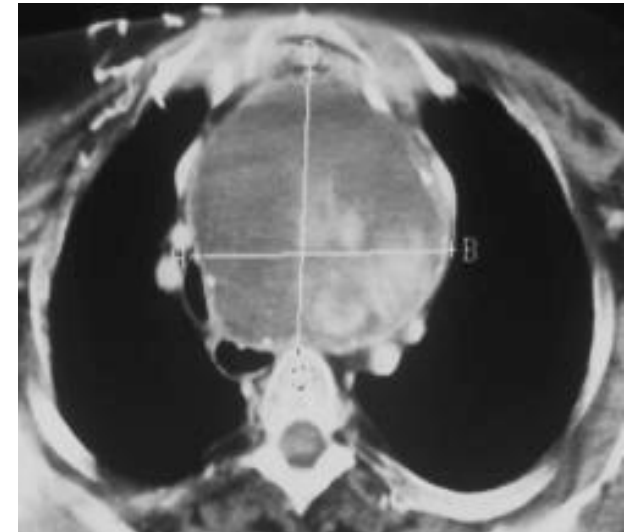
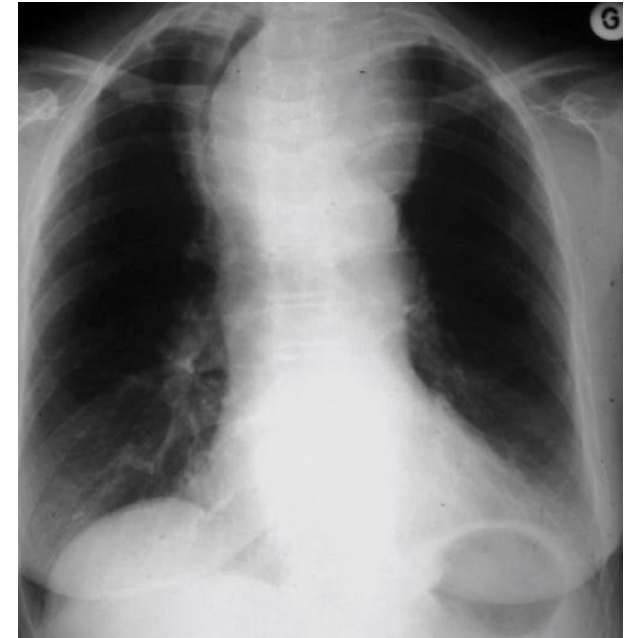
A quel symptomatologie correspond l'image?

- A.  Syndrome VCS
- B.  Claude Bernard Horner
- C.  Epanchement pleural / péricardique
- D.  Paralysie n. phrénique
- E.  Paralysie n. récurrent



Patiente 80 ans avec stridor
inspiratoire et expiratoire, sans plaintes
Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. 👎 Paralysie diaphragmatique
- B. 👎 Thymome
- C. 👎 Tumeur neurogène
- D. 👎 Hernie hiatale
- E. 👍 Goitre plongeant droite



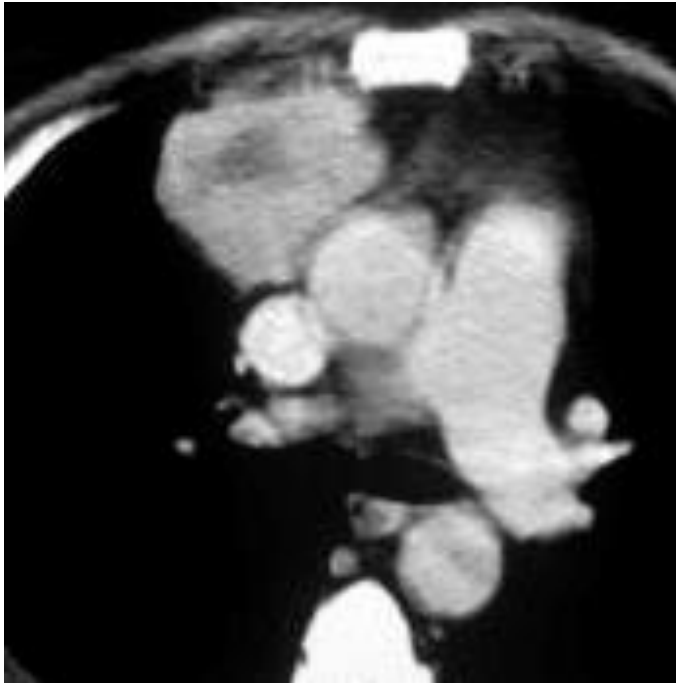
*Compression voies aériennes
résection par cervicotomie*

Patiente de 60 ans, présente comme découverte fortuite, au CT scan thoracique une masse médiastinale. Quel est le diagnostic le plus probable?



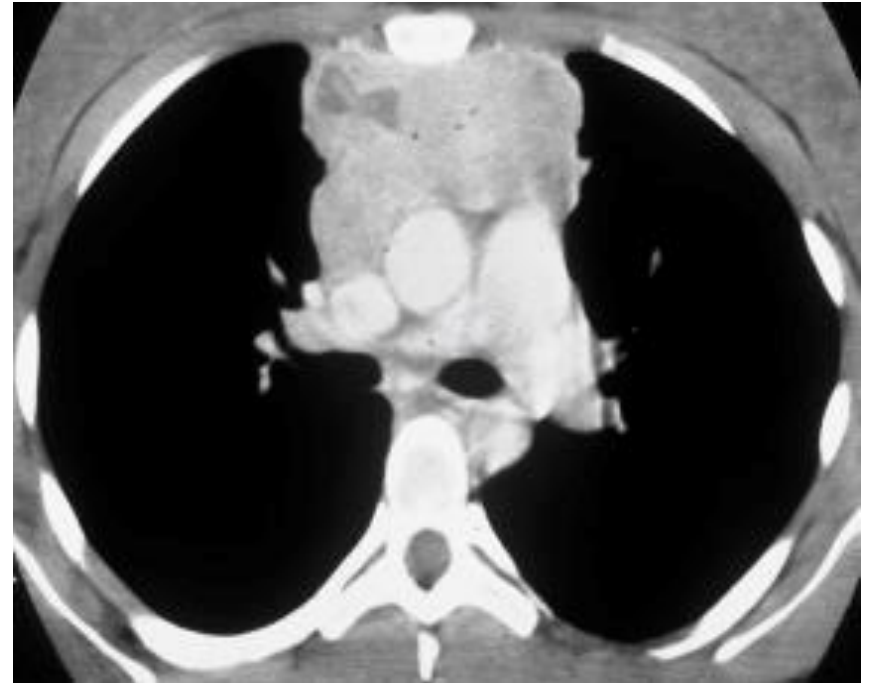
- A. 👍 Thymome
- B. 👎 Lymphome
- C. 👎 Tumeur neurogène
- D. 👎 Kyste bronchogénique
- E. 👎 Tératome

MÉDIASTIN ANTÉRIEUR TUMEURS THYMIQUES



Age 50-70 ans
Masse unique
Résection

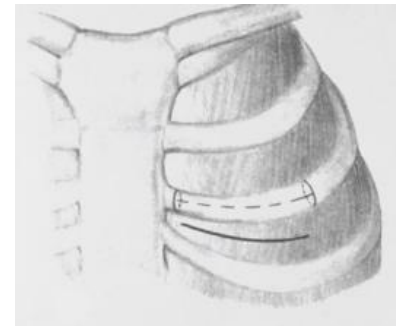
LYMPHOME MÉDIASTINAL



Tumeur du jeune adulte
Aspect nodulaire
CHT (RT-CHT)

Comment obtenir le diagnostic
anatomo-pathologique des masses
médiastinales antérieures?

- A. 👎 Médiastinoscopie
- B. 👎 Thoracotomie
- C. 👎 Cytoponction transthoracique
- D. 👍 Médiastinotomie prasternale
- E. 👍 True-cut sous CT



Préparation QCM examen final

Chirurgie thoracique

1. Cancer du poumon / plèvre
2. Tumeurs du médiastin
3. Traumatisme thoracique
4. Infections

Patient présente après accident de moto des difficultés de respirer et une tension artérielle de 90/60 mmHg.

Quelles sont les constats corrects?

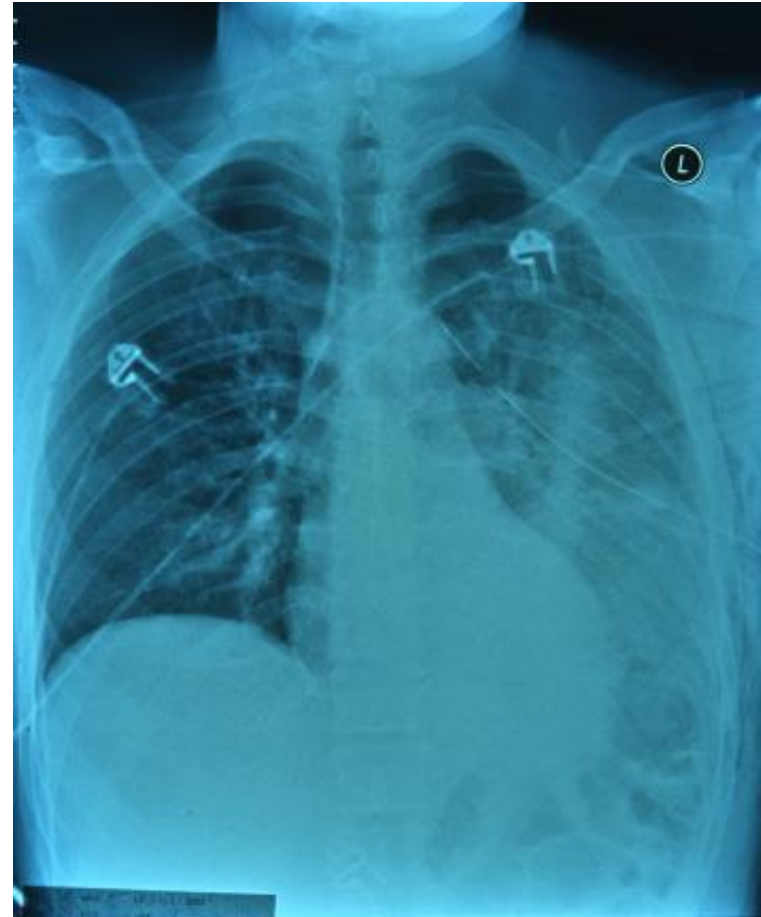
- A. 👍 Fractures de côtes
- B. 👍 Emphysème sous-cutané
- C. 👍 Contusion pulmonaire à gauche
- D. 👎 Pneumothorax sous tension à droite
- E. 👍 Pneumothorax sous tension à gauche



PNEUMOTHORAX SOUS TENSION



Shift médiastinal $\searrow$ retour veineux
Traitement immédiat!



Décompression immédiate de la
cavité (*drainage thoracique*)

Fracture de côtes / volet 67%

Rupture diaphragmatique

Lésions cardiaques

Tamponnade



Traumatisme thoracique

Lésions médiastinales 20%

Vaisseaux / Bronches / Œsophage



Pneumothorax 20%

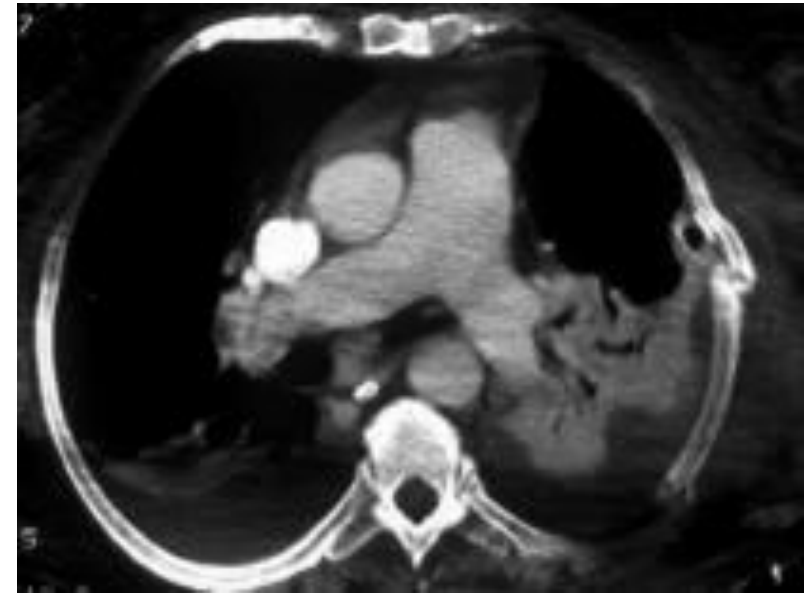
Hémothorax 20%

Contusion pulmonaire 20%

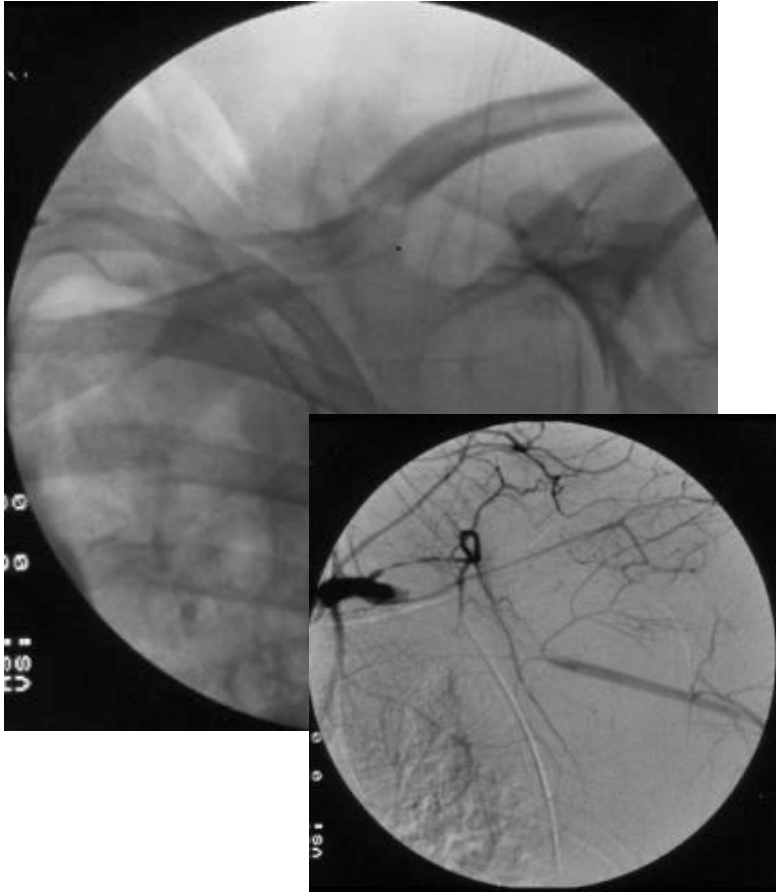


FRACTURE DE CÔTE UNE LÉSION NON-BANALE!

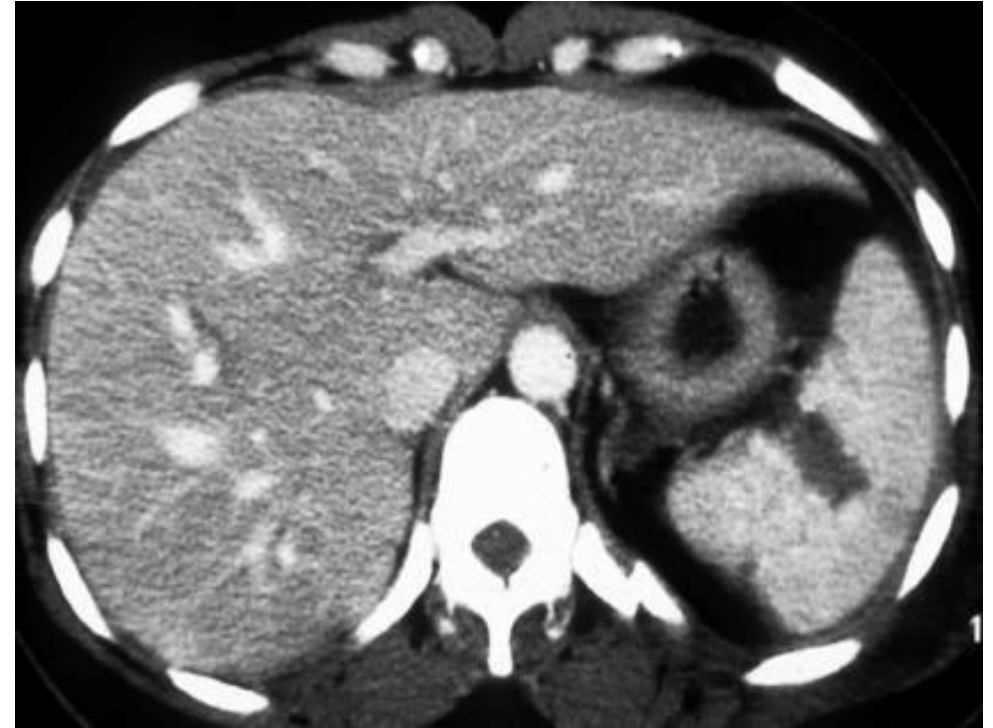
- Hypoventilation liée aux douleurs
- Encombrement, atélectasie
- Pneumonie, insuffisance respiratoire



1. 👍 Administration d'antidouleurs efficaces primordial
2. 👍 Toux efficace = critère d'un traitement efficace
3. 👍 Anesthésie péridurale continue si nécessaire
4. 👍 Toilette bronchique (bronchoscopie) en cas de sécrétions
5. 👎 Sédation maximale

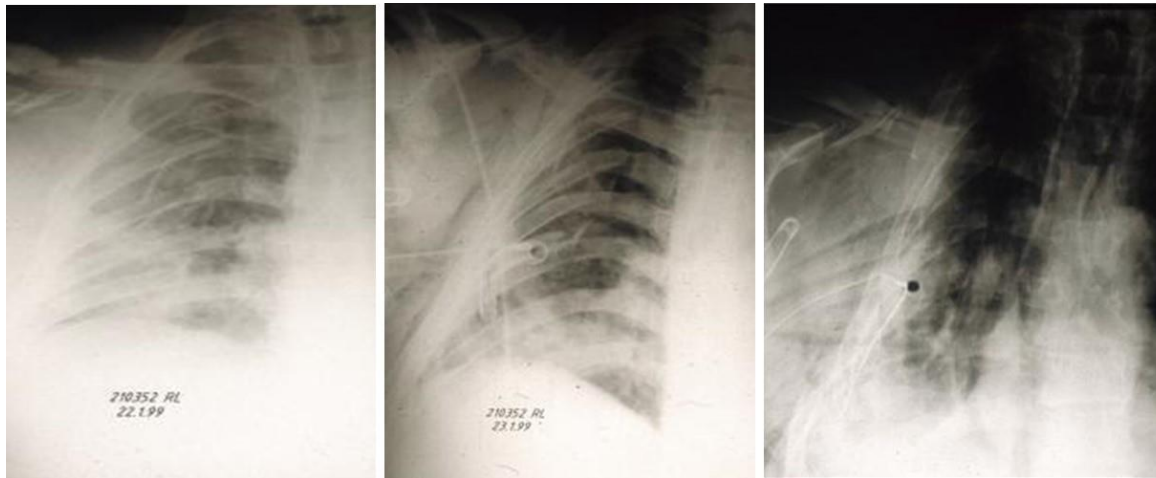
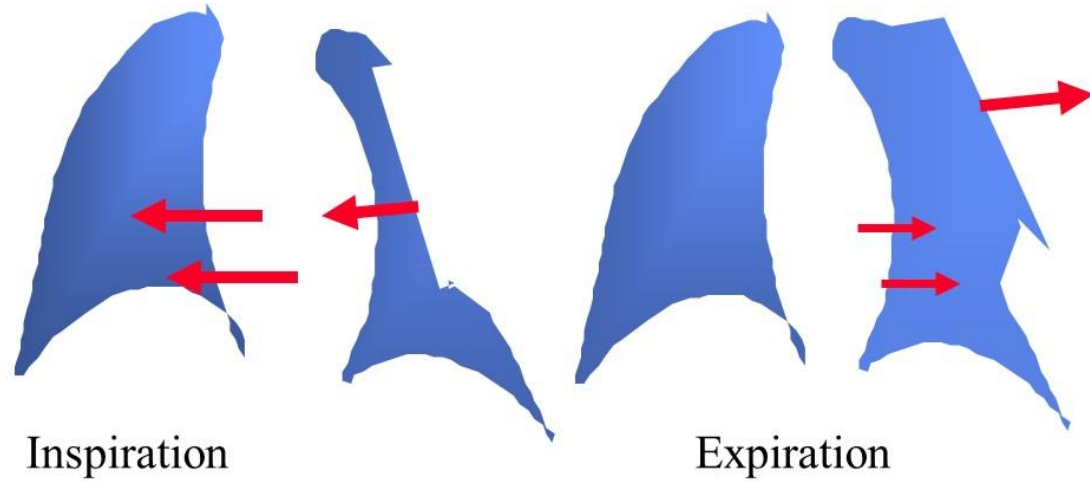
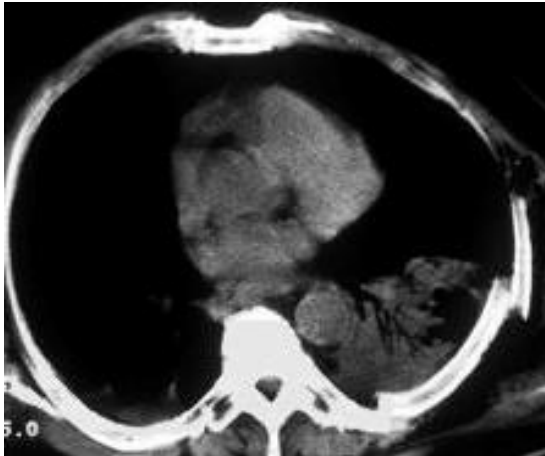


Fracture de 1^{ère} côte /clavicule:
→ Lésions neuro-vasculaires du bras



Fractures de côtes basi-thoraciques:
→ Lésions spléniques /hépatiques

VOLET THORACIQUE ≥ 2 COTES ≥ 2 NIVEAUX
INSUFFISANCE RESPIRATOIRE



Diminution progressive du volume
cage thoracique (restriction tardive)

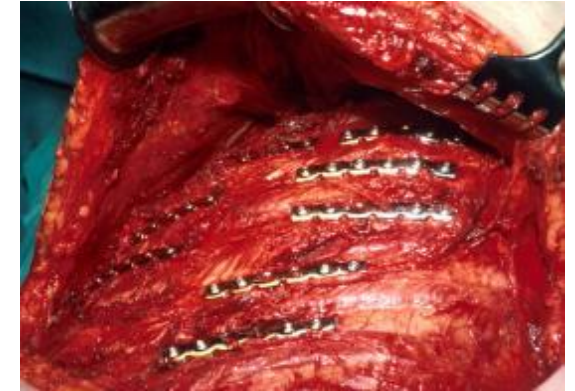
VOLET THORACIQUE AVEC INSUFFISANCE RESPIRATOIRE

TRAITEMENT

1. 👍 Anesthésie péridurale
2. 👍 Ventilation mécanique (attelle interne)
3. 👍 Ostéosynthèse (attelle externe)
4. 👍 Ventilation CPAP
5. 👎 Morphium i.v.

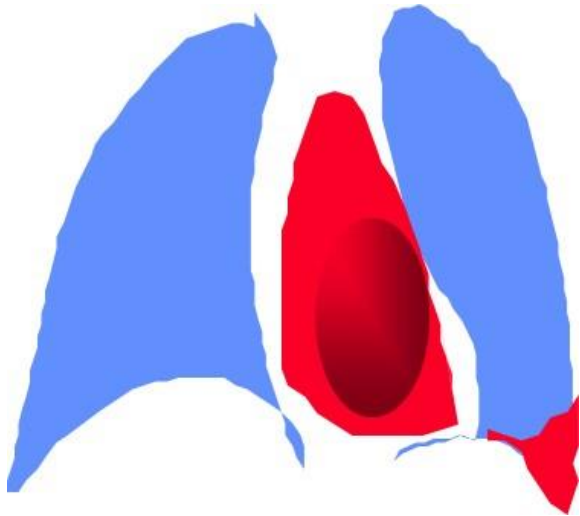


Ventilation mécanique



Ostéosynthèse

CONTUSION CARDIAQUE

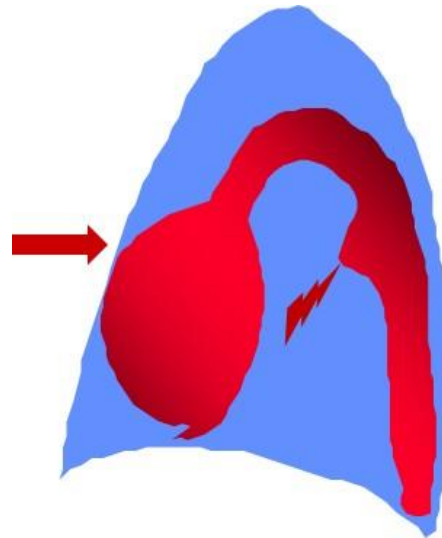


Troubles de rythme



Echocardiographie
Télémétrie 24h

RUPTURE AORTIQUE

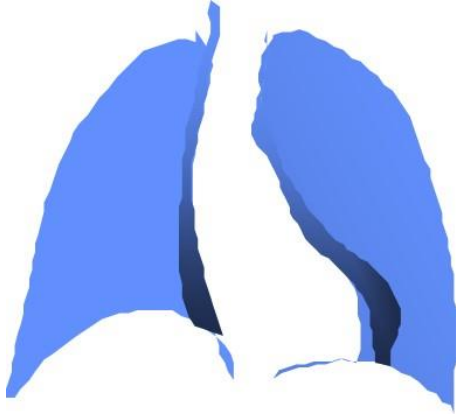


Choc hémorragique; faux anévrisme

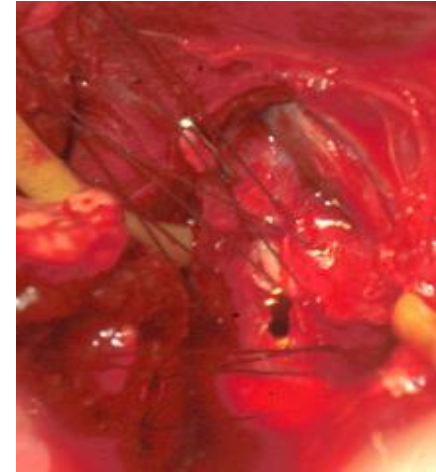


Réparation par prothèse endovasculaire

RUPTURE BRONCHIQUE



Pneumomédiastin



Suture bronchique

1. 👍 Emphysème médiastinal / cervical
2. 👍 Diagnostic par bronchoscopie
3. 👍 Suture par thoracotomie
4. 👎 Traitement par stents

TRAUMATISME THORACIQUE: INDICATIONS OPÉRATOIRES



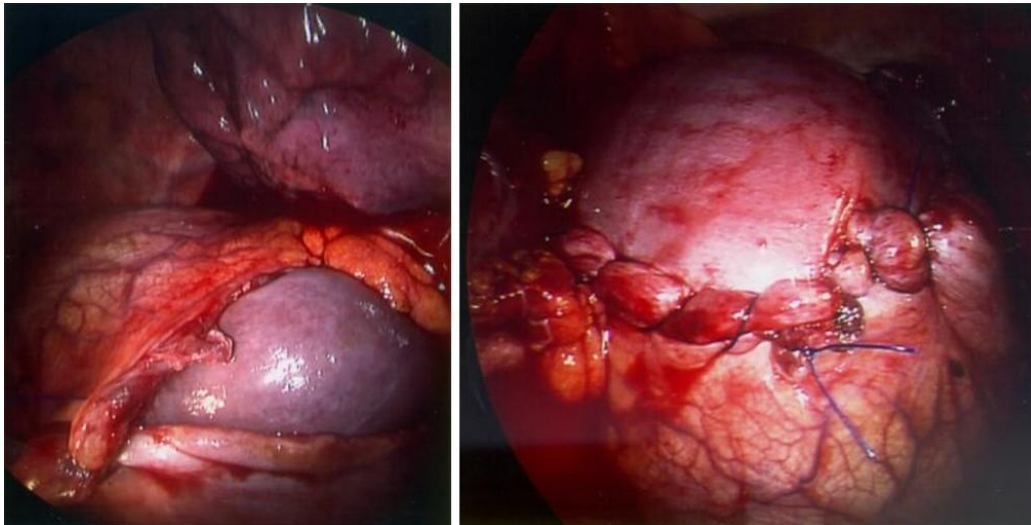
Hémiclamshell en urgence

1. 👍 Suspicion de lésion cardiaque par arme blanche, tamponnade
2. 👎 Contusion pulmonaire
3. 👍 Hémorragie continue (*drainage* $> 300\text{ml/h}$)
4. 👍 Rupture bronchique, lésions des gros vaisseaux / œsophage
5. 👍 Rupture de diaphragme (*laparotomie*)

Radiographie après accident de voie public

Diagnostic le plus probable:

- A. 👎 Contusion cardiaque
- B. 👎 Atélectasie du poumon gauche
- C. 👎 Rupture aortique
- D. 👎 Contusion pulmonaire
- E. 👍 Rupture diaphragmatique



Préparation QCM examen final

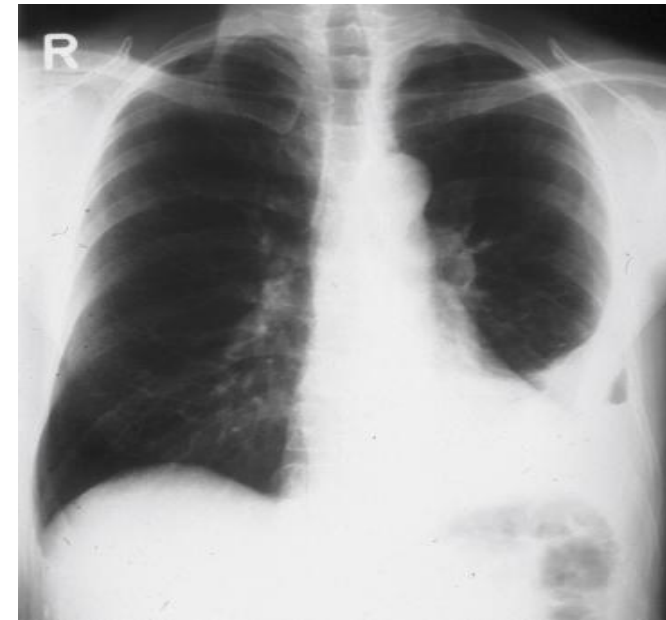
Chirurgie thoracique

1. Cancer du poumon / plèvre
2. Tumeurs du médiastin
3. Traumatisme thoracique
4. Infections

Une patiente 55 ans présente 3 semaines après
une infection respiratoire un état fébrile persistant
Radiographie du thorax : Epanchement pleural
Thoracocentèse: Exsudat neutrophilique

Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. 👍 Empyème para pneumonique
- B. 👎 Epanchement pleural malin
- C. 👎 Chylothorax
- D. 👎 Insuffisance cardiaque
- E. 👎 Epanchement tuberculeux



ÉPANCHEMENT PLEURAL: DIAGNOSTIC

Les 4 causes les plus fréquentes d'épanchement pleural ?

1. Insuffisance cardiaque
2. Pneumonie
3. Tumeur maligne
4. Embolie pulmonaire

ÉPANCHEMENT PLEURAL : THORACOCENTÈSE / DRAINAGE

EXSUDAT

Taux plevre - sérum

LDH >0.6

Protéines > 0.5



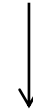
Tumeur
Infection / TBC
Embolie pulmonaire

TRANSSUDAT

Taux plevre - sérum

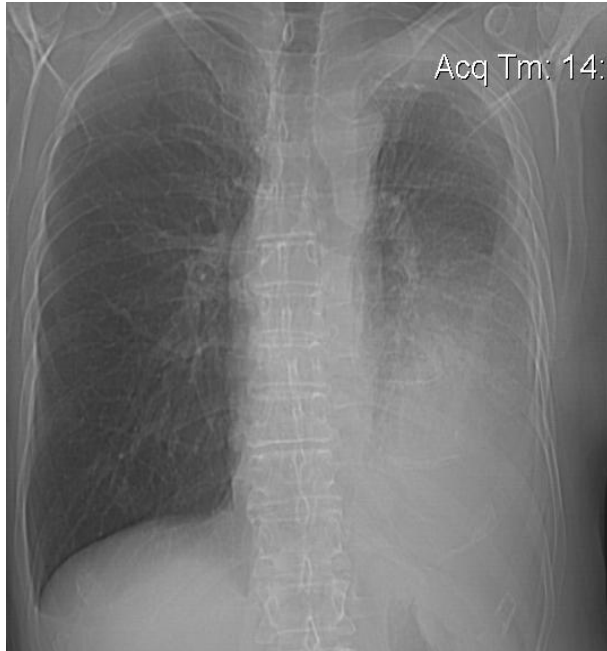
LDH <0.6

Protéines < 0.5



Insuffisance cardiaque
Cirrhose
Pathologie rénale
Hypoprotéinémie

ÉPANCHEMENT PLEURAL: CT SCAN

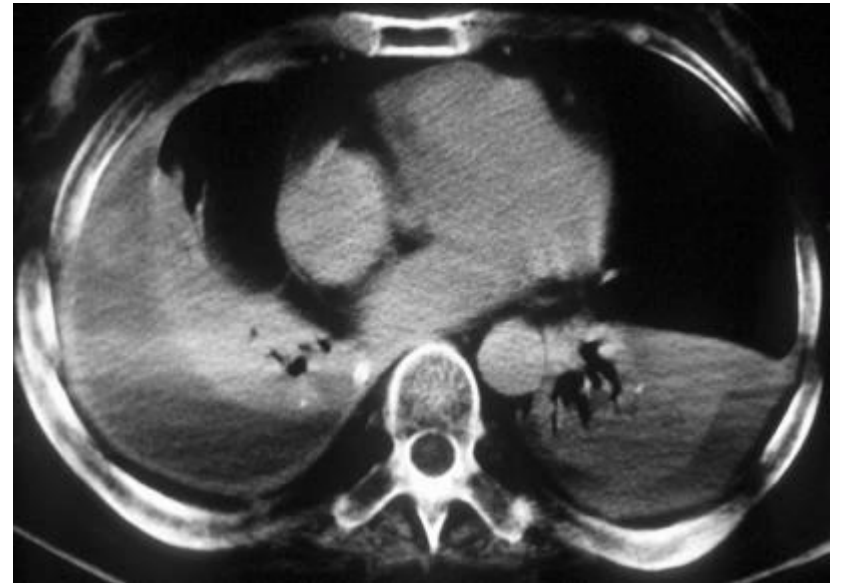


Détection / caractérisation des pathologies pleurales
Discriminations des pathologies pleurales / pariétales / pulmonaires

EMPYÈME PLEURAL

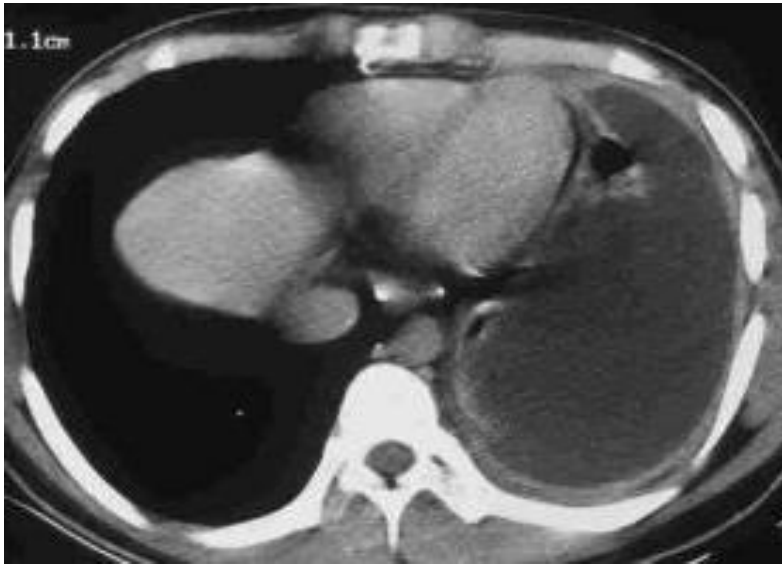
Comment le traiter?

- A. 👍 Décortication
- B. 👎 Drainage
- C. 👎 Fibrinolyse
- D. 👎 Thoracoscopie
- E. 👎 Traitement antibiotique seul



Perte de poids, fatigue, douleurs thoraciques
Inflammation (température / CRP)
Epanchement purulent / Gram+ / pH<7.1
CT rehaussement pleural pariétal / restriction

EMPYÈME PLEURAL: LES BUTS DU TRAITEMENT



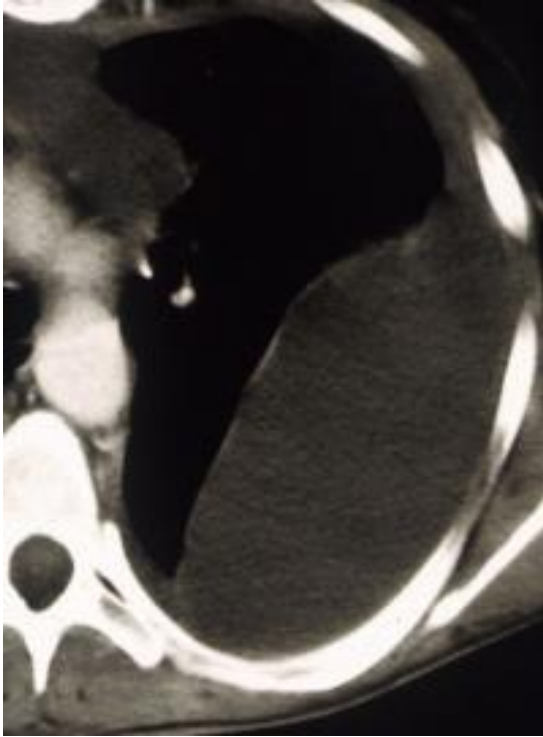
Patient avec empyème TB



1 an après par antibiothérapie seule

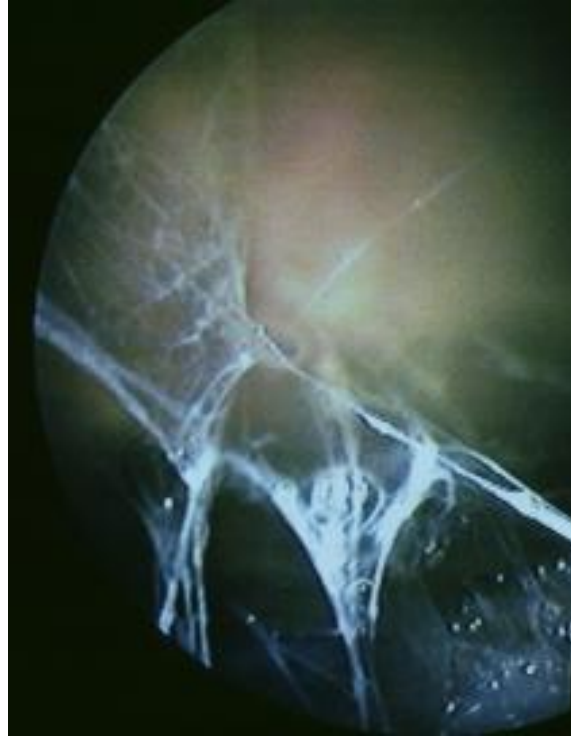
1. Traitement de l'infection en cours
2. Prévention d'une récurrence
3. Prévention de la restriction tardive

EMPYEME PLEURAL: TRAITEMENT SELON CHRONICITÉ



STADE I

ANTIBIOTIQUES
DRAINAGE



STADE II

THORACOSCOPIE
FIBRINOLYSE



STADE III

DÉCORTICATION

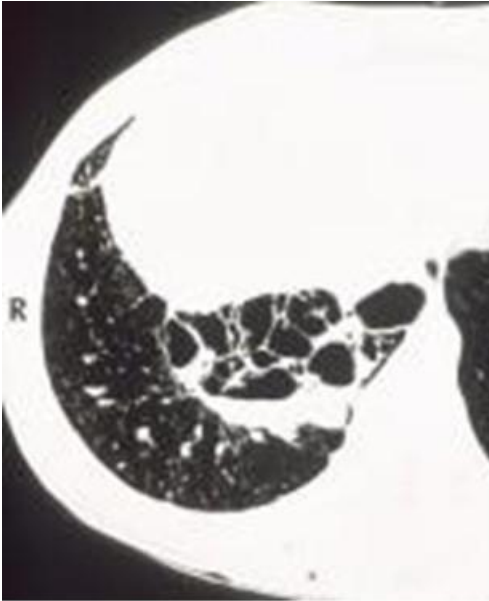
Un patient de 35 ans, non-fumeur, connu pour une épilepsie, présente un état fébrile et des crachats malodorants.

Quel est le diagnostic le plus probable?

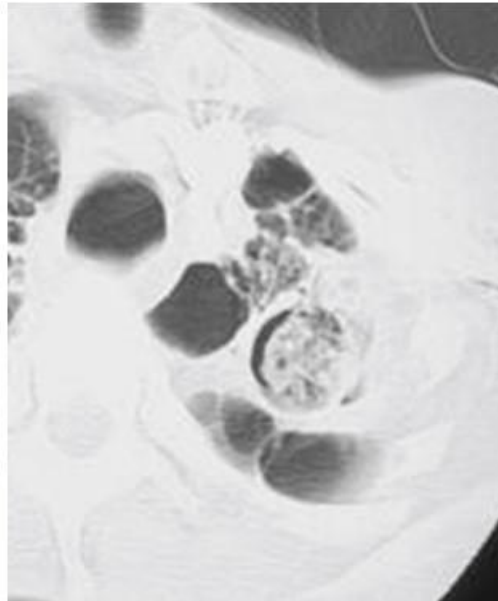
- A. 👍 Abscès pulmonaire
- B. 👎 Métastase
- C. 👎 Plaques pleurales
- D. 👎 Cancer de l'œsophage
- E. 👎 Empyème



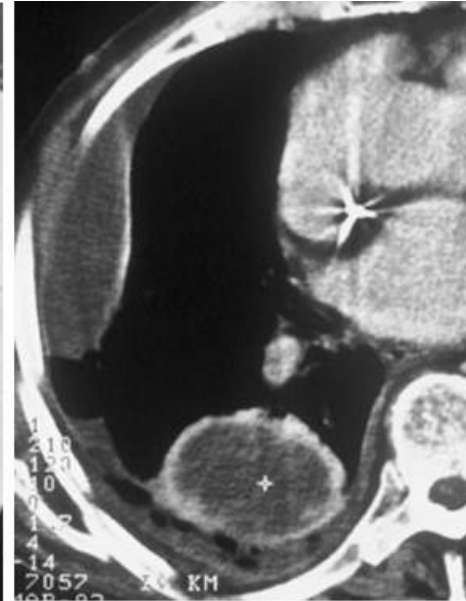
DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DES LÉSIONS EXCAVÉES



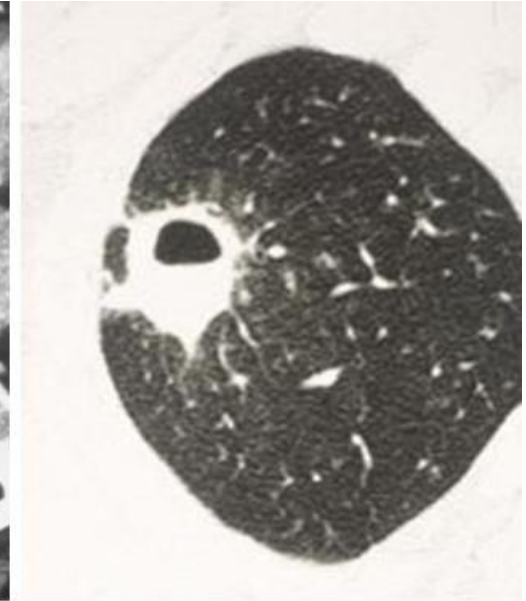
Bronchectasies



Aspergillome



Cancer bronchique



Lymphome / TB

Merci de votre attention

...et bonne chance!

ÉPANCHEMENT PLEURAL THORACOCENTÈSE / DRAINAGE

Protéines /LDH	→	Exsudat vs Transsudat
Cellularité	→	Neutrophilie vs Lymphocytose
Cytologie	→	Tumeur ?
Culture	→	Empyème ?
pH <7.1	→	Empyème
Triglycerides	→	Chylothorax

ÉPANCHEMENT PLEURAL: DIAGNOSTIC

Situation clinique détermine l'approche diagnostique

Insuffisance cardiaque?

Infection respiratoire / état fébrile?

Maladie tumorale connue?

Thrombose veineuse profonde / embolie pulmonaire?

Insuffisance rénale terminale / hépatique?